ACEI/ARB
β-R拮抗剂
CCB
利尿剂

专题串联·高血压一线药 ABCD

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

形成血压：有血 利尿剂；射血 β-R拮抗剂；拦着 二氢吡啶类CCB、ACEI/ARB；存着

（一）血管紧张素转化酶抑制剂 ACEI（普利）、血管紧张素受体拮抗剂 ARB（沙坦）

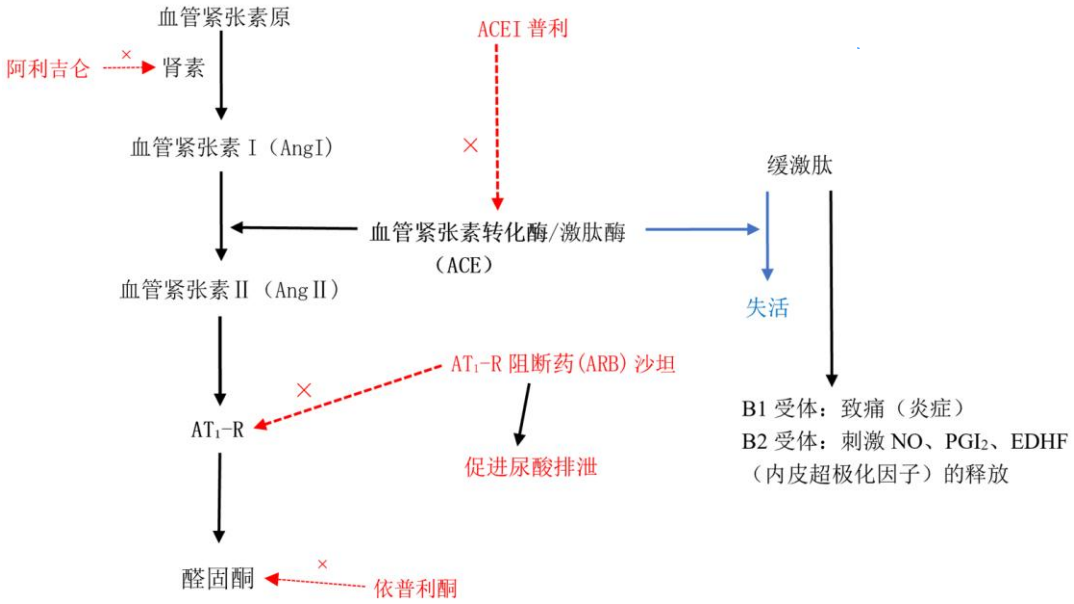
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI（ARB+脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲）

（脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的 AngII则联合 ARB 使用）

排水排钠　舒血管

ACEI比ARB循证医学证据更充分　不良反应少

降压特点：①降压缓慢而持久：ACEI 在 3-4 周、ARB 在 6-8 周达到最大降压作用；②ARB 治疗剂量窗宽



β-受体拮抗剂

（二）β-R 阻断剂（如美托洛尔、阿替洛尔、卡维地洛）

复习《生理学》：

①激动心脏 β_1-R：四正效应（心肌收缩能力↑、心率↑、传导↑、心输出量↑）

②激动球旁细胞 β_1-R：肾素↑→RAAS 兴奋

③激动血管、支气管 β_2-R：血管舒张、支气管舒张　支气管哮喘、冠脉痉挛、雷诺病不用β-R拮抗剂

降压特点：

①特别适合青年高血压（交感亢进为主：心输出量高、心率快、肾素 ttsx 活性高）

②长期用药特别是较高剂量治疗后不要突然停药、否则易出现反跳现象

（三）钙通道阻滞剂/钙拮抗剂 CCB

①**注意区分二氢吡啶类（反射性心率↑）如硝苯地平、氨氯地平 VS 非二氢吡啶类如维拉帕米、地尔硫卓**

②降压特点：对血脂、血糖、尿酸无明显影响

（四）利尿剂

机制：早期排钠排水，后期血管舒张（血管平滑肌细胞缺钠→钠钙交换↑→细胞内钙↓）

